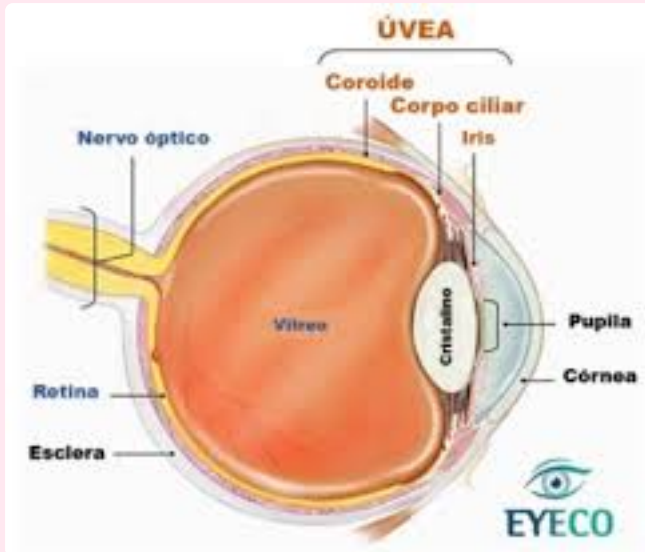


Uveíte

Conceito

Processo inflamatório envolvendo a úvea (íris + corpo ciliar + coroide)



→ Divisão anatômica:

- Anterior: seguimento anterior
- Intermediária: cavidade vítrea + pars plana
- Posterior: retina + coroide
- Panuveíte

Etiologia

#hlab27 #AIJ #DII #Sarcoidose

- Idiopática (maioria);
- Pode ser associada á processos:
 - Traumáticos
 - Inflamatórios
 - Anterior
 - HLAB27 (Espondilite anquilosante);
 - Artrite Idiopática Juvenil;
 - Doença Inflamatória Intestinal;
 - Sarcoidose;
 - Doença de Behçet;
 - Nefrite túbulo intersticial;
 - Intermediária
 - Esclerose Múltipla;

- Sarcoidose;
- Nefrite túbulo intersticial;
- Posterior
 - Síndrome de Vogt-Koyangi-Harada;
 - Leucemia;
 - Lupus;
 - Doença de Behçet;
 - Esclerose Múltipla;
- Doenças infecciosas

#sífilis
#endoftalmite
#tuberculose
#toxoplasmose
#lyme
#toxocara

 - Vírus (HSV, VZV, CMV)
 - Bactérias (endoftalmite, sífilis, tuberculose, etc.)
 - Parasitas/vermes (toxoplasmose, doença de Lyme, toxocara, Bartonella sp. ou outras infecções atípicas).

Quadro Clínico

Anterior

- Uni ou bilateral;
- Dor;
- Visão turva;
- Fotofobia;
- Hiperemia perilimbar (rubor ciliar);
- Pupila constricta com formato irregular em comparação com o olho não afetado (pela formação de sinéquias posteriores);
- Sinais: células e flare na câmara anterior, sinéquias posteriores, precipitados ceráticos.



Intermediária

- Geralmente não associada á dor;
- Visão trua;
- Moscas volantes;

- Sinais: células e turvação vítrea, manchas brancas no vítreo, manchas brancas na pars plana, edema macular cistoide.

Posterior

- Perda de visão;
- Disfotopsias
 - **Disfotopsia Positiva:** Percepção de brilho (glare), halos, raios de luz ou flashes, muitas vezes causados por luzes externas à noite.
 - **Disfotopsia Negativa:** Presença de uma sombra escura ou arco na periferia temporal da visão.
- Sinais: lesões coriorretinianas, branqueamento da retina, bainha vascular.

Panuveíte

- Sintomas: olho vermelho e dolorido; acuidade visual gravemente reduzida; moscas volantes.
- Sinais: células e flare na câmara anterior, células e turvação vítrea, lesões coriorretinianas, branqueamento da retina.

Tratamento

- Nesse caso, não tem muito o que fazer antes de encaminhar para o especialista, foca no ciclopégico (previne a formação de sinéquias);
 - Ciclopentolato 1%: 1 gota de 2-3 vezes ao dia;
 - 👉 Por quê?
 - reduz espasmo do músculo ciliar
 - melhora dor e fotofobia
- Atropina 1%: pode ser uma boa opção na falta do ciclopégico;
 - *Midríase reduz o contato íris-cristalino e a formação de aderências inflamatórias.*
 - Faz uma gota antes do encaminhamento;
 - Evitar se **Glaucoma de ângulo fechado**;